

NOTULEN

Yang dilaksanakan pada : Kamis / 25 April 2024
Pukul : 10.00 WIB – SELESAI
Materi : Rapat Direksi RS
Tempat : Ruang Meeting Kantor PT DPM

Berikut hasil notulen :

NO.	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	PHS pasien meningkat	- Membuka ruang HD - Bagaimana kebutuhan tenaga - Peralatan - Rekrutmen perawat untuk Klinik	- Langkah yang di ambil sudah tepat dengan memanfaatkan ruangan-ruangan yang bisa digunakan - Segera lakukan pengajuan CITO. Batasi cuti untuk tenakes dan berikan ekstra lembur untuk tenakes yang bertugas - Sudah di ambil menggunakan barang barang lama dari PHM, MS dan KRI - Pengajuan untuk Klinik dilakukan selanjutnya. Lebih difokuskan kepada pengajuan CITO karena peningkatan pasien. - Di fokuskan dalam pelayanan agar tidak diputus pelayanan oleh BPJS - Evaluasi berkelanjutan untuk program program yang berjalan	Manajerial RS dan SDM PT
2.	Peningkatan Pasien di PHM	- Transit pasien di Hall Cemara - Perawat libur di panggil jaga dan kasir - Dipilih oleh dinkes untuk melatih terkait maternal care, stunting, SHK dan pelaporan terkait maternal dan gizi bekerja sama DPJP untuk menjadi pemateri FKTP	- Harus ada komunikasi bahwa tempat tersebut hanya untuk transit - Perhitungan beban karyawan disesuaikan dengan TT - Diperbolehkan tetapi harus tetap dikoordinasikan dengan keuangan dan kebutuhannya di awal.	Direksi RS, SDM PHM dan Keuangan PT. DPM



3.	BPJS PHS	1. Tindak lanjut pending 2. Catatan audit dari BPJS (kunjungan berulang, fragmentasi, eswl kunjungan lebih dari 5 kali) 3. Menarik kunjungan baru di rawat jalan dan rujukan internal disesuaikan dengan indikasi	1. Audit → mencari kebenaran terkait coding. Selama RS tidak memiliki argumentasi dan harus mengembalikan ke BPJS. Maka, dana yang di kembalikan itu harus sesuai proporsi apakah sudah di bayarkan ke DPJP terkait atau belum. 2. PHS dan PHM harus sosialisasi ke DPJP terkait kebijakan kebijakan BPJS (ex: PRB)	Manajerial dan Direksi
4.	Outbreak atau tren?	1. Penambahan SDM 2. Inventaris barang 3. Analisis	1. SDM: - Direktur RS lakukan evaluasi semua unit yang bersinggungan dengan IRNA terkait beban kerjanya. - Pastikan punya rencana ketika outbreak turun akan di taruh mana penambahan karyawan yang sudah dilakukan → diskusi dengan SDM PT apakah akan ada kontrak jangka pendek atau ada opsi lain? 2. Barang-barang inventaris harus di inventarisir kembali dan di kembalikan ke unit yang memiliki 3. Kabid dan Manajerial melakukan analisis terkait outbreak atau tren 4. Kedua direktur sampaikan ke unit → Outbreak merupakan sarana promosi gratis	Direksi RS, SDM PT dan Direksi PT
5.	DPJP	1. DPJP Rujuk Internal 2. DPJP Bedah Syaraf (BS) 3. Pengadaan Alat Bedah Syaraf	1. Perlakukan DPJP seperti karyawan lain (lakukan orientasi juga) agar dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada 2. Koordinasi dengan pengadaan terkait alat-alat penunjang Bedah Syaraf yang ada di sukorejo ditawarkan ke DPJP di Malang	Direksi RS, Manajerial PT dan seluruh SDM

			3. Sudah di lakukan order ke pengadaan tetapi masih ada beberapa alkes yang belum ada. 4. Jangan sampai ada kerugian terkait risiko tinggi ketika alkes belum lengkap. Saat operasi BS harus ada diskusi khusus dengan unit unit yang bersangkutan terkait proporsi dan lainnya.	
--	--	--	--	--

Pemimpin Rapat



dr. Sadi Hariono, MMRS

Malang, 25 April 2024

Notulis



Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui,
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

 PT. DISA PRIMA MEDIKA


Endang Susilowati